

CD73129961C1A

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

J37066291290E

ANTONIO CARLOS DA SILVA

IDADE: 68 PESO: 97 ALTURA: 175 PROFISSÃO: Adm. Empresa

SINTOMAS: Sonolência / Memória ruim.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dne

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 7:30

COCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N 3x sem.FUMO: ☒ S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 1 maço / dia

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globoso CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Eliquis / Selozok / Rosuvastatina /

Omaprazol / maguete / Buspatalin / oagclive

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA cloridrato

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Dor na coluna / sinusite.

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

15105 - Comprim

25



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**

Antonio Carlos Da Silva

DN.: 04/04/1957 - 68 Anos

PID: 1855211

Atendimento: 16233352

Data do Exame: 13/05/2025

Medico solicitante: Dr.(a) Fernanda de Carvalho Lopes Robbi -
CRM-144975

Antonio Carlos da Silva

Conclusões:

Polissonografia dividida em duas fases, inicialmente realizada basal (1ª fase) e depois com auxílio de CPAP / BPAP (2ª fase). Técnica "Split-Night" utilizada de acordo com: (The impact of Split-Night Polysomnography – Sanders et al. *Sleep*, Vol. 23, nº1, 2000.)

1. Eficiência do sono 81.5% (>85%);
2. Latência para o sono 15.6 min. (<30min.);
3. Proporção de sono de ondas lentas 29.5% (13 a 23%);
4. Proporção de sono REM 5.0 % (20 a 25%);
5. Latência para o sono REM 162.0 min. (70 a 120min.);
6. Índice de despertar 47.0 (<10.0);
7. Não foi detectado arritmia cardíaca;
8. Atonia muscular em sono REM preservada;
9. Aumento dos movimentos periódicos dos membros inferiores resultando em fragmentação do sono, podendo estar parcialmente e/ou totalmente associado a instabilidade respiratória;
10. Índice de apnéia + hipopnéia acentuadamente elevado na 1ª fase do exame (33,9 eventos/hora), onde os eventos respiratórios obstrutivos dos tipos apnéia e hipopnéia ocorreram independentes do decúbito, resultando em: (A) - Dessaturação variando entre leve e moderada da oxi-hemoglobina, permanecendo 0.7% menor que 90% e saturação basal de 95%. (B) - Ronco intenso e descontinuo. (C) - Fragmentação do sono devido ao aumento de despertares. (D) - Aumento dos movimentos de membros;
11. Moderada elevação da frequência de eventos respiratórios não apneicos, não hipopneicos, decorrentes da elevação da resistência de vias aéreas superiores, resultando em períodos de ronco intenso e descontinuo, culminando com despertares e fragmentação do sono, sem no entanto, alterar significativamente a saturação da oxi-hemoglobina, foram observados durante todos os decúbitos;
12. Respiração bucal mesclada a nasal durante a 1ª fase do exame;
13. Após o início do CPAP/BPAP (2ª fase do exame) e ajuste da pressão do mesmo no transcorrer da noite, observou-se a tendência em reversão dos fenômenos descritos nos parágrafos acima.

OBS1: A máscara utilizada foi nasal modelo Inspira M..

Comentários:

Síndrome da Apnéia e Hipopnéia do Sono de acentuada intensidade e independente do decúbito, resultando em fragmentação moderada do sono e dessaturação variando entre leve e moderada da oxi-hemoglobina + Síndrome

Unidade:
Hospital Sírio-Libanês (SP)
CRM 903904

Telefone:
+55 (11) 3394-0200

Responsável técnico:
Dr. Luiz Francisco Cardoso
CRM/SP 46059

Portal do Paciente:
paciente.hsl.org.br

Site:
hsl.org.br

